FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

DOCUMENTATION TECHNIQUE
ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION

TYPE D'ÉVALUATION : INITIALE | MODIFICATION | EXTENSION | RENOUVELLEMENT

RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Comparaison BBRAUN avec version précédente:
- Retrait dossier papier
- Ajout d'informations tout au long du texte sur les DM sans destination médicale (surligné jaune)
- Ch 10 (surligné bleu) : retrait de la référence ANSM pour le degré d'innovation au profit du FUI
- Ch 18.7(surligné bleu) : reformulations sans impact de fond

ÉDITION JANVIER 2024

FICHE TECHNIQUE À L'USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED
Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 3 du 22/12/2023

GMED
GROUPE LNE

SOMMAIRE

I RECOMMANDATIONS SUR LA FORME DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE PRÉSENTÉE POUR ÉVALUATION 3

1 **Démarche** 3

2 **Structuration de la Documentation Technique** 3

a Composition 3
b Cohérence de terminologie 4
c Structure globale du dossier électronique 4
d Sommaire de la Documentation Technique 5

3 **Le dossier électronique** 5

a Fichiers électroniques PDF 5
b Utilisation des signets et pagination 5
c Envoi du dossier électronique à GMED 6

II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION 7

→ RECOMMANDATIONS SUR LA FORME DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE PRÉSENTÉE POUR ÉVALUATION

1 Démarche

L'évaluation de la Documentation Technique implique une analyse précise et exhaustive de documents pouvant contenir un nombre important de pages, au global. Ainsi, la qualité de la forme de ces dossiers (signets, pagination, PDF sans recherche possible, etc.) varie et impacte l'organisation interne.
La première partie de cette recommandation est un guide sur la forme que doit prendre la Documentation Technique soumise à une évaluation auprès de nos services. Ainsi, il donne des instructions pour la préparation de la Documentation Technique uniquement sur sa forme.

Cette démarche s'inscrit dans le sens donné par la Règlementation (UE) 2017/745 qui précise dans la partie de l'Annexe II portant sur la Documentation Technique : *« La documentation technique et, le cas échéant, un résumé de celle-ci, que le fabricant doit établir, sont présentés de manière claire, organisée et non ambiguë, sous une forme facilement consultable, [...]. »*

Note importante : Dans le cadre d'une évaluation de la conformité sur la base de l'Examen UE de Type selon l'Annexe X du Règlement (UE) 2017/745, la Documentation Technique devra être obligatoirement accompagnée d'un échantillon représentatif des dispositifs produits envisagés (dénommé « Type ») ainsi que des éléments de preuve démontrant que le type a été fabriqué en conformité avec la Documentation Technique concernée.

2 Structuration de la Documentation Technique

a → Composition

Une Documentation Technique comprend, à minima, un exemplaire sous format électronique, **ou dossier électronique.**

Ce dossier est indispensable pour mener à bien l'évaluation de la conformité du dispositif. Ce dossier doit être soumis à GMED en une seule fois et de façon complète. La transmission de documents supplémentaires en cours d'évaluation (annexes, amendements, correctifs, ou autres) n'est pas acceptée et ne sera pas prise en compte.
Le dossier doit être rédigé en français ou en anglais. Le rapport d'évaluation de GMED sera rédigé dans la même langue que celle de la Documentation Technique soumise.
Dans le cas où le processus d'évaluation nécessite une consultation tierce partie (telles que : Autorités Compétentes, EMEA, panel d'experts, etc.), les sections dédiées de la Documentation Technique devront être transmises dans la langue requise par les parties consultées.

En parallèle, la transmission à GMED des éléments complémentaires suivants est fortement conseillée :
- Des photos pertinentes du dispositif et de son emballage commercial, avec identification de la position des différents étiquetages et documents d'accompagnement ;
- Un échantillon dans son emballage commercial (tel que prévu d'être mis sur le marché), dans la mesure du possible, et clairement identifié comme tel.

b → Cohérence de terminologie

De manière générale, la terminologie utilisée doit être strictement cohérente sur l'ensemble du dossier.
Ainsi, si la dénomination du dispositif a évolué (ou changé) au cours de sa conception et que les précédentes dénominations apparaissent dans les documents de preuve (par exemple), cet historique doit être clairement mentionné en introduction de la Documentation Technique. Cette omission peut amener à ne pas retenir les documents comme éléments de preuve (par exemple).
De même, la dénomination d'éléments relatés dans la Documentation Technique, par exemple matière première, conditionnement, doit être en cohérence avec la dénomination de l'élément sur le document de preuve. Quand ce n'est pas le cas, l'information doit être explicitée dans la Documentation Technique afin que l'évaluateur retienne le document comme opposable.

c → Structure globale du dossier électronique

i. Dossier de notification initiale, de renouvellement ou de modification

D'une manière générale, il est rappelé que la Documentation Technique doit être conçue de façon à correspondre à la trame du rapport GMED et des rapports spécifiques. Ces documents GMED diffèrent selon la typologie des dispositifs médicaux (emballage, stérilisations, etc.).

En ce sens, il est recommandé en préambule de la Documentation Technique que soit rappelé :

- **L'objet de l'envoi du dossier** et la **portée de l'évaluation attendue** (notamment si la Documentation Technique porte sur plusieurs dispositifs) ;
- Une **correspondance précisant, pour chacun des différents points** (Partie 2 du présent document), **les réponses et les liens vers la Documentation Technique correspondante** ou la justification de la non-application ou du non-impact de la modification sur le point spécifique exposé dans le rapport.

ii. Dossier de demande de compléments

À l'issue de l'évaluation de la Documentation Technique, il arrive qu'un certain nombre d'interrogations aient été soulevées et fassent l'objet de Non-Conformité(s) transmise(s) au fabricant. Dans ce cas, le fabricant est notifié de ces constats et le formulaire de Non-Conformités lui est adressé.
En retour, il est recommandé de répondre aux Non-Conformités dans l'ordre demandé. La présence d'une correspondance précisant pour chacune des différentes Non-Conformités, les réponses et les liens vers la Documentation Technique correspondante (ou la justification de la non-application ou du non-impact de la modification) sera attendue. Cette correspondance est à intégrer en préambule du dossier de réponse.

d → Sommaire de la Documentation Technique

La Documentation Technique comporte **un sommaire couvrant la totalité de la Documentation Technique.** Ces sommaires détaillent et spécifient (liste non exhaustive) :

- Les titres des documents ;
- Le numéro du document (référence, révision, date d'application) et le nom du fichier électronique où le trouver ;
- Numéro des chapitres ;
- Numéro des annexes ;
- La pagination précise ;
- Le sommaire de chaque annexe.

3 Le dossier électronique

a → Fichiers électroniques PDF

Le dossier électronique comprend plusieurs fichiers électroniques. Ces fichiers doivent correspondre **au format PDF** (Portable Document Format). L'utilisation de la recherche active de mots **(indexable)** à l'intérieur de chacun des fichiers PDF doit être possible sur **l'intégralité des documents.**

Le nom d'un fichier doit permettre d'établir un lien rapide et clair avec le sommaire du dossier. Néanmoins, par souci technique, le **chemin d'accès au fichier est limité à 40 caractères et ne doit pas contenir de caractères spéciaux** (@ _ - [ ], etc. sont interdits).

Il est recommandé d'intégrer aux dossiers des **schémas, illustrations et photos avec leurs couleurs et résolutions d'origine.**

Enfin, l'utilisation de plusieurs fichiers de petite taille est préférable à un fichier unique et volumineux en nombre de pages.

b → Utilisation des signets et pagination

En guise d'intercalaire, le format PDF propose **l'utilisation de signets (en arborescence)** afin d'organiser le document et de permettre une navigation cohérente avec cette organisation. L'utilisation de ces signets sur chacun des documents du dossier électronique est indispensable. Naturellement, chaque signet devra faire écho au sommaire du dossier électronique (ou de l'annexe correspondante).
Enfin, chacune des pages doit comporter, soit en en-tête, soit en pied de page, les numéros de pagination, paragraphe, chapitre et document s'y référant.

c → Envoi du dossier électronique à GMED

Chaque Documentation Technique doit être envoyée en un exemplaire électronique à GMED via une plateforme de téléchargement de votre choix.

Le lien pour initier le téléchargement est à envoyer à l'attention de votre Chef de Projet Certification et de l'Assistante Certification ainsi qu'à la boîte mail générique : GMEDExamenCE@lne-gmed.com.

Afin d'améliorer l'identification du dossier électronique, il vous est demandé de mentionner le numéro de projet GMED dans l'objet de l'email.

En cas de difficulté à transmettre votre Documentation Technique en format électronique, merci de vous rapprocher de votre contact désigné au sein de GMED.



II → ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION

La présente liste des éléments à fournir, dans le cadre d'une évaluation de la Documentation Technique par GMED, est établie selon les exigences détaillées en Annexe II du Règlement (UE) 2017/745.

Dans le cadre des activités d'évaluation réalisées par GMED, la Documentation Technique fait l'objet d'une revue préliminaire afin de vérifier le caractère complet de la Documentation Technique transmise et identifier les points à compléter avant d'engager l'évaluation, le cas échéant. L'évaluation est planifiée en fonction des résultats de cette revue.

Note : Dans le cadre de produits relevant de l'Annexe XVI « Liste des groupes de produits n'ayant pas de destination médicale prévue visés à l'article 1er, paragraphe 2 » du Règlement (UE) 2017/745, le terme « dispositif médical » s'entend comme le terme « dispositif ».
Également, dans le cadre de produits relevant de l'Annexe XVI, le terme « consommateur » est utilisé. Par « consommateur » on entend une personne physique sur laquelle un produit n'ayant pas de destination médicale prévue est destiné à être utilisé, tel qu'indiqué dans le Règlement d'exécution (UE) 2022/2346.

Note : Dans le cas où la Documentation Technique couvre un dispositif ayant à la fois une destination médicale et non médicale, il est recommandé de clairement identifier et distinguer les éléments concernant la destination médicale et non médicale, en particulier dans les sections suivantes :

- Partie I - Informations générales :
  - Section 3 : Désignation commerciale du dispositif médical
- Partie II - Description et spécification du dispositif médical, y compris les variantes et accessoires :
  - Section 6 : Classe du dispositif et justification
  - Section 8 : Description de l'usage revendiqué
- Partie III - Informations devant être fournies par le fabricant :
  - Section 12 : Documents d'accompagnement
- Partie V - Exigences générales en matière de sécurité et de performances :
  - Section 15 : Tableau de synthèse des exigences de l'Annexe I du Règlement (UE) 2017/745
- Partie VI - Analyse bénéfice/risque et gestion des risques :
  - Section 16 : Analyse bénéfice/risque visée à l'Annexe I du Règlement (UE) 2017/745
  - Section 17 : Dossier de gestion des risques
- Partie VII - Vérification et validation du produit :
  - Section 18 : Données précliniques : Démonstration de conformité des caractéristiques du dispositif médical, en lien avec les normes, documents de référence et/ou état de l'art appliqué en vue de démontrer la sécurité préclinique du dispositif et le respect des spécifications, en particulier :
    - Section 18.4 : Évaluation mécanique, physique, chimique, électrique, etc.
    - Section 18.9 : Ingénierie de l'aptitude à l'utilisation
- Partie VIII - Surveillance après commercialisation :
  - Section 19 : Description des dispositions prises pour la surveillance du dispositif après commercialisation, y compris le plan de suivi clinique après commercialisation (SCAC)
  - Section 20 : Données post-marché

À noter que la distinction entre la destination médicale et non médicale peut être également nécessaire dans d'autres sections en fonction des caractéristiques du dispositif objet de l'évaluation.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES	1	**FABRICANT LÉGAL** Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse complète du fabricant tel que défini dans le Règlement. **Note 1 :** La structure juridique responsable de la mise sur le marché du dispositif médical doit être explicite et cohérente sur l'ensemble de la Documentation Technique et les informations fournies par le fabricant (notice, manuel d'utilisation, étiquetage, brochure, catalogue et publications similaires, etc.)
	2	**MANDATAIRE DANS L'UNION EUROPÉENNE (SI APPLICABLE)** Nom ou raison sociale et adresse complète du mandataire dans l'Union européenne.
	3	**DÉSIGNATION COMMERCIALE DU DISPOSITIF MÉDICAL** 3.1. Identification du dispositif et de ses variantes et des différentes configurations du dispositif, accompagnées de leurs références commerciales. 3.2. Identification des États membres dans lesquels il est envisagé de vendre le produit ou dans lesquels le produit est déjà commercialisé.
	4	**CERTIFICATION EXISTANTE** 4.1. Identification de l'attestation CE de système qualité couvrant le dispositif (section 1 de l'Annexe IX du Règlement (UE) 2017/745). 4.2. Identification de l'attestation de conformité à la section 2 de l'Annexe IX du Règlement (UE) 2017/745, le cas échéant. 4.3. Le dispositif a-t-il fait l'objet d'une évaluation de conformité sous un autre statut ou d'un enregistrement hors territoire de l'UE ?

II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION (suite)

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES	5	**DÉCLARATIONS**

5.1. Une déclaration indiquant si un produit d'origine animale est utilisé ou non pour la fabrication du dispositif.

Cf. Fiche technique : Matériau d'origine animale - Éléments à fournir

Note 5.1.1 : Un produit dérivé est un matériau ou une substance obtenu(e) à partir d'un tissu d'origine animale par un procédé de fabrication (exemple : collagène, gélatine, enzymes, ...).

Note 5.1.2 : À titre d'exemple, les réactifs d'origine biologique utilisés au cours du procédé de fabrication de dispositifs médicaux peuvent être des peptones d'origine bovine, des acides aminés d'origine porcine, des anticorps monoclonaux murins, du sérum de veau fœtal (utilisé dans les cultures cellulaires).

Note 5.1.3 : Dans le cas de l'évaluation d'une modification d'un dispositif médical utilisant un matériau d'origine animale (ou introduction d'une variante d'un produit existant ou extension de gamme), le cas échéant, l'absence d'impact de la modification sur la sécurité virale et la réduction du risque d'Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles (EST) (si applicable) est à documenter.

Note 5.1.4 : Les dérivés du suif sont traités à la section 18.3 de cette fiche technique.

5.2. Une déclaration indiquant si le dispositif incorpore ou non une substance susceptible d'être considérée comme un médicament (en référence à l'Annexe I section 12.1 du Règlement (UE) 2017/745).

Cf. Fiche technique : Substance médicamenteuse incorporée à titre accessoire dans un dispositif médical - Éléments à fournir

5.3. Une déclaration indiquant si le dispositif incorpore ou non une substance dérivée du sang humain.

5.4. Une déclaration indiquant si le dispositif incorpore ou non des substances ou combinaisons de substances destinées à être introduites dans le corps humain et absorbées par le corps humain ou dispersées localement dans celui-ci (en référence à l'Annexe I, section 12.2 du Règlement (UE) 2017/745).

Cf. Fiche technique : Dispositifs médical composé de substances ou de combinaisons de substances destinées à être introduites dans le corps humain par un orifice du corps ou par application sur la peau et absorbées par le corps humain ou dispersées localement dans celui-ci - Éléments à fournir

II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION (suite)

II – DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU DISPOSITIF MÉDICAL, Y COMPRIS LES VARIANTES ET ACCESSOIRES	6	**CLASSE DU DISPOSITIF ET JUSTIFICATION** 6.1. Raisons pour lesquelles le produit constitue un dispositif médical et/ou raisons pour lesquelles le produit constitue un produit n'ayant pas de destination médicale listé à l'Annexe XVI du Règlement (UE) 2017/745. 6.2. Classification selon l'Annexe VIII du Règlement (UE) 2017/745 : règle appliquée et argumentaire de classification. **Note 6.2 :** Dans le cas de groupes de certains produits actifs n'ayant pas de destination médicale, se référer aux règles de reclassification du Règlement d'exécution (UE) 2022/2347.
	7	**DESCRIPTION DU DISPOSITIF** 7.1. Identifiant Unique du Dispositif (IUD-ID). 7.2. Code EMDN (ou GMDN). 7.3. Le cas échéant, description des accessoires, des autres dispositifs médicaux et des produits autres que des dispositifs médicaux, destinés à être utilisés en combinaison avec le dispositif (**couverts et non couverts** par l'évaluation). 7.4. Le cas échéant, identification et description des différentes configurations ou variantes du dispositif. 7.5. Le cas échéant, identification et description du (ou des) logiciel(s) associé(s). 7.6. Description de la présentation commerciale (dispositif dans son emballage) incluant des photos détaillées.

II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION (suite)

II – DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU DISPOSITIF MÉDICAL, Y COMPRIS LES VARIANTES ET ACCESSOIRES

8

DESCRIPTION DE L'USAGE REVENDIQUÉ

8.1. Destination médicale revendiquée.

Note 8.1 : Dans le cas de produits n'ayant pas de destination médicale listés à l'Annexe XVI du Règlement (UE) 2017/745, la destination revendiquée du produit n'est pas médicale.

8.2. Utilisateurs et/ou consommateurs* auxquels le dispositif est destiné.

* Voir la définition associée dans la note en préambule de la partie 2 : Éléments à fournir dans le cadre d'une évaluation de cette fiche technique : terme utilisé dans le cadre de produits relevant de l'Annexe XVI du Règlement (UE) 2017/745.

8.3. Indications et conditions d'utilisation prévues, en lien avec la maladie, la pathologie et/ou le handicap traité, population de patients et/ou d'utilisateurs et/ou de consommateurs* visée, critères de sélection applicables aux patients et/ou utilisateurs et/ou consommateurs*.

Note 8.3 : Dans le cas de produits n'ayant pas de destination médicale listés à l'Annexe XVI du Règlement (UE) 2017/745, il n'y a pas d'indications.

8.4. Principe de fonctionnement et mode d'action du dispositif, incluant l'utilisation d'accessoires qui ne sont pas évalués dans le cadre de cette évaluation, le cas échéant.

8.5. Performances cliniques revendiquées pour la destination prévue, au regard de la maladie, de la pathologie et/ou du handicap traité.

Note 8.5.1 : Pour les prothèses articulaires, veuillez préciser les performances fonctionnelles revendiquées (exemple : mouvements angulaires relatifs minimal et maximal, prévus entre les parties du squelette auxquelles la prothèse articulaire se rapporte, usure présumée des surfaces articulaires, ...).

Note 8.5.2 : Dans le cas de produits n'ayant pas de destination médicale listés à l'Annexe XVI du Règlement (UE) 2017/745, les revendications relatives aux performances cliniques sont limitées à la capacité du produit à atteindre sa destination prévue.

8.6. Bénéfices cliniques revendiqués.

Note 8.6 : Dans le cas de produits n'ayant pas de destination médicale listés à l'Annexe XVI du Règlement (UE) 2017/745, l'obligation de démontrer l'existence d'un bénéfice clinique s'entend comme une obligation de démontrer la performance du produit, comme indiqué à la section 9 de l'article 61 du Règlement (UE) 2017/745.

8.7. Contre-indications, effets secondaires et mises en garde.

8.8. Durée de vie du dispositif (durée de maintien des performances cliniques en conditions normales d'utilisation) : selon le dispositif médical considéré, il s'agit d'être précis en faisant par exemple la différence entre la durée pendant laquelle le dispositif reste performant et la durée pendant laquelle le dispositif reste dans le corps humain mais n'est plus performant.

Note 8.8 : Dans le cas de produits n'ayant pas de destination médicale listés à l'Annexe XVI du Règlement (UE) 2017/745, les revendications relatives aux performances cliniques sont limitées à la capacité du produit à atteindre sa destination prévue.

8.9. Délai de péremption.

II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION (suite)

II – DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU DISPOSITIF MÉDICAL, Y COMPRIS LES VARIANTES ET ACCESSOIRES

9

CARACTÉRISTIQUES DES COMPOSANTS, DU PRODUIT FINI (DISPOSITIF) ET LE CAS ÉCHÉANT DES ACCESSOIRES COUVERTS PAR L'ÉVALUATION

9.1. Description générale des éléments fonctionnels clés tels que les pièces ou composants (formulation, composition, fonctionnalité).

Note 9.1 : Pour les dispositifs médicaux comprenant des particules de taille inférieure à 100 nm, doivent figurer dans la documentation fournie par le fabricant les caractéristiques telles que : l'état d'agglomération/l'agrégation, la composition (par exemple : la composition chimique et la structure), la taille des particules et leur distribution, la pureté/l'impureté, la forme, la solubilité (hydrophobicité, liposolubilité, hydrosolubilité), la stabilité, l'aire surfacique, la chimie des surfaces, la charge surfacique, les caractéristiques du revêtement, etc.

9.2. Spécifications des matières premières (cf. note 9.4.1) : physiques, chimiques, biologiques, etc. avec leur référence, numéro de révision et date de révision.

9.3. Spécifications des additifs, des contaminants et des résidus de processus de fabrication (cf. note 9.4.1) : physiques, chimiques, biologiques, etc. avec leur référence, numéro de révision et date de révision.

9.4. Spécifications du conditionnement primaire (celui en contact direct avec le dispositif médical) avec sa référence, numéro et date de révision.

Note 9.4.1 : Matières premières, additifs, contaminants, résidus de processus de fabrication et articles de conditionnement primaire dont le changement peut remettre en question la conformité aux exigences générales en matière de sécurité et de performances.

Note 9.4.2 : La liste des spécifications requises aux points précédents, ainsi que le nom et l'adresse des fournisseurs et distributeurs, sont à transmettre selon le format suivant, également sous format électronique copiable (Annexe 1 de cette fiche technique).

Matières premières, additifs, contaminants, résidus de processus de fabrication et articles de conditionnement primaire	Spécifications (Caractéristiques physique, de surface, composition chimique, dimension, etc.)	Fournisseur / Adresse	Distributeur / Adresse

9.5. Identification des matériaux en contact avec le patient (implantés ou non) et/ou l'utilisateur et/ou le consommateur* par contact direct ou indirect avec le corps humain.

9.6. Spécifications du produit fini : ensemble des spécifications techniques, telles que caractéristiques, dimensions du dispositif et de toute variante/configuration.

9.7. Le cas échéant, l'ensemble des spécifications techniques des accessoires, telles que caractéristiques, dimensions de l'accessoire et de toute variante/configuration.

9.8. Si applicable, plans et schémas avec leurs références, numéro de révision et dates de révision ainsi qu'une photo.

II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION (suite)

II – DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU DISPOSITIF MÉDICAL, Y COMPRIS LES VARIANTES ET ACCESSOIRES	10	**RÉFÉRENCE À DES GÉNÉRATIONS PRÉCÉDENTES ET SIMILAIRES DU DISPOSITIF** 10.1. Évolution d'un dispositif médical déjà marqué CE par le fabricant (fournir une présentation générale de la (ou des) génération(s) précédente(s) du dispositif produite(s) par le fabricant, s'il en existe). 10.2. Développement sur la base d'un dispositif médical similaire de la concurrence (fournir une présentation générale des dispositifs similaires identifiés disponibles sur le marché de l'UE ou international, s'il en existe). 10.3. Dispositif médical complètement nouveau. 10.4. Explication de toute nouvelle caractéristique. Le caractère innovant ou non du dispositif est à préciser et à développer le cas échéant. Pour ce faire, le degré de nouveauté du dispositif est à définir en prenant en compte les critères énoncés dans le Formulaire Unique d'Information, onglet FI-INF.
	11	**HISTORIQUE DES MODIFICATIONS (SECTION NON APPLICABLE DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION INITIALE)** 11.1. Évolution du dispositif depuis sa mise sur le marché (date de mise sur le marché à préciser). 11.2. Identification des modifications pas encore notifiées. 11.3. Évolution règlementaire, normative, de l'état de l'art.

II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION (suite)

III – INFORMATIONS DEVANT ÊTRE FOURNIES PAR LE FABRICANT

	DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT
12	**Note 12 :** Dans le cas de produits n'ayant pas de destination médicale listés à l'Annexe XVI du Règlement (UE) 2017/745, les informations fournies avec le produit ne doivent comporter aucune allégation ou déclaration relative au bénéfice clinique. Se référer aux annexes applicables du Règlement d'exécution (UE) 2022/2346 qui listent le contenu de la notice d'utilisation et de l'étiquette spécifique à ces produits. 12.1. Notice d'utilisation : • Contenu de la notice d'utilisation spécifique du dispositif ou manuel d'utilisation (ou projet) dans les langues acceptées dans les États membres dans lesquels il est envisagé de vendre le dispositif ; • Si applicable, document(s) référencé(s) au niveau de la notice, à destination des patients ou utilisateurs ou consommateurs* (exemple : technique opératoire, carte implant, brochure, etc.). **Note 12.1.1 :** En cas de mise en œuvre d'instruction d'emploi sous forme électronique, la conformité au Règlement d'exécution (UE) 2021/2226 sera évaluée. Dans ce cadre, la Documentation Technique doit inclure l'analyse d'impact des instructions d'emploi sous forme électronique, notamment en lien avec les informations suivantes : ◦ Caractéristiques des composants, du produit fini (dispositif) et le cas échéant des accessoires couverts par l'évaluation (cf. section 9) ; ◦ Description des documents d'accompagnement ; ◦ La démonstration de conformité aux exigences applicables du Règlement d'exécution (UE) 2021/2226 est à documenter. Il est recommandé d'utiliser un format de tableau de synthèse ; ◦ Dossier de gestion des risques (cf. section 17) ; ◦ Ingénierie de l'aptitude à l'utilisation (cf. section 18.9) ; ◦ Analyse d'impact sur la validation des procédés spéciaux (exemple : procédés de conditionnement, de stérilisation, etc.) ; ◦ Tableau de synthèse des exigences de l'Annexe I du Règlement (UE) 2017/745 (EGSP) (cf. section 15). **Note 12.1.2 :** Veuillez noter que le Règlement d'exécution (UE) 2021/2226 établit également certaines exigences ayant trait au contenu et à la présentation sur le web des instructions d'emploi électroniques fournies en sus d'une notice d'utilisation complète sur support papier. 12.2. Étiquetage : • La (ou les) étiquette(s) présente(s) sur le dispositif et sur son conditionnement, par exemple le conditionnement de chaque unité, le conditionnement de vente, le conditionnement de transport en cas de conditions particulières de manipulation, dans les langues acceptées dans les États membres dans lesquels il est envisagé de vendre le dispositif ; • Le texte et éléments graphiques de l'emballage commercial (maquette), dans les langues acceptées dans les États membres dans lesquels il est envisagé de vendre le dispositif. **Note 12.2 :** Se référer aux exigences de la section 23 de l'Annexe I du Règlement (UE) 2017/745, aux normes produits, EN ISO 15223-1, etc. 12.3. Autres documents d'accompagnement (exemple : technique opératoire, manuel d'utilisation, de maintenance, étalonnage, brochure, catalogue et publications similaires, etc.).

II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION (suite)

IV – INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ET LA FABRICATION

13 INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION (SI APPLICABLE)

13.1. Planification du projet de conception (version finale) permettant la compréhension des étapes de la conception du dispositif.

13.2. Identification des éléments de sortie de la vérification de conception.

13.3. Enregistrements des résultats et conclusions du transfert de conception et développement.

13.4. Comptes rendus de toutes les revues de conception conduites pendant la réalisation du projet.

14 INFORMATIONS SUR LA FABRICATION

14.1. Nom et adresse des fournisseurs/distributeurs des matières premières, additifs, contaminants, résidus de processus de fabrication et articles de conditionnement primaire.

Note 14.1.1 : Il s'agit des composants principaux, matières premières, additifs, contaminants, résidus de processus de fabrication et articles de conditionnement primaire dont le changement peut remettre en question la conformité aux exigences générales en matière de sécurité et de performances.

Note 14.1.2 : L'identification des fournisseurs et distributeurs est à transmettre (Annexe 1 de cette fiche technique).

14.2. Logigramme de fabrication (identifiant les procédés mis en œuvre en précisant s'ils sont validés ou vérifiés, ainsi que les contrôles en cours de fabrication et finaux réalisés), y compris lorsque des étapes sont sous-traitées.

Note 14.2.1 : Ce document est à transmettre également sous format électronique copiable (Annexe 2 de cette fiche technique).

Note 14.2.2 : Le ou (les) nettoyage(s) intermédiaire(s) est (ou sont) à également à indiquer, le cas échéant.

14.3. Description des méthodes de fabrication et de contrôles réalisés, y compris lorsque des étapes sont sous-traitées.

Note 14.3 : La nature des contrôles en cours de fabrication et sur le produit final est à transmettre. Les critères de contrôle sur les caractéristiques critiques du dispositif, y compris quand ils sont sous-traités, sont à transmettre.

14.4. Description du (ou des) procédé(s) de fabrication validé(s) et rapport(s) de validations (QO et QP), y compris lorsque les procédés sont sous-traités.

Note 14.4.1 : Celle-ci doit a minima identifier les informations suivantes :
- Description du procédé validé avec l'identification précise de l'équipement concerné ;
- Identification des rapports de validation associés (QO/QP) avec leur référence, numéro de révision et date de révision ;
- Identifications des paramètres critiques du procédé ainsi que les intervalles de tolérance validés (mini/maxi).

Note 14.4.2 : La liste des procédés est à transmettre également sous format électronique copiable (Annexe 3 de cette fiche technique).

14.5. Description de l'(ou des) environnement(s) de fabrication accompagnée de la classification correspondante.

14.6. Identification des sites de fabrication et des certifications SMQ des sous-traitants (le cas échéant), des organismes certificateurs et validité des certificats en cours, le cas échéant.

Dans le cas où un procédé aurait fait l'objet d'une évaluation antérieure par GMED dans le cadre du Règlement (UE) 2017/745, sous un format « Master-File » (validation d'un procédé couvrant plusieurs dispositifs couverts par différentes Documentations Techniques et/ou dépendants de différentes catégories et/ou groupes génériques) :

14.6.1. Identification du (ou des) procédé(s) concerné(s).

14.6.2. Identification du numéro et de la date du rapport d'évaluation GMED, statuant favorablement.

14.6.3. Argumentaire relatif à l'inclusion du dispositif, objet de l'évaluation, dans la validation du procédé déjà évalué (inclusion du produit dans une famille définie sans remise en cause du worst-case).

II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION (suite)

V – EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PERFORMANCES

15 TABLEAU DE SYNTHÈSE DES EXIGENCES DE L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745 (EGSP)

15.1. Les exigences générales en matière de sécurité et de performances qui s'appliquent au dispositif et les raisons pour lesquelles les autres exigences ne s'y appliquent pas.

15.2. La (ou les) méthode(s) utilisée(s) pour démontrer la conformité avec chaque exigence générale en matière de sécurité et de performances applicable.

15.3. Les normes harmonisées, spécifications communes ou autres solutions appliquées.

Note 15.3 : La liste des normes et documents appliqués est à transmettre également sous format électronique copiable (Annexe 4 de cette fiche technique).

15.4. La référence précise des documents contrôlés fournissant la preuve du respect de chaque norme harmonisée, spécification commune ou autre méthode appliquée pour démontrer la conformité avec les exigences générales en matière de sécurité et de performances. La localisation des documents contrôlés dans la Documentation Technique, et le cas échéant, dans le résumé de la Documentation Technique, est à préciser.

VI – ANALYSE BÉNÉFICE/RISQUE ET GESTION DES RISQUES

16 ANALYSE BÉNÉFICE/RISQUE VISÉE À L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

L'analyse bénéfice/risque du fabricant, visée à l'Annexe I sections 1 et 8 du Règlement (UE) 2017/745, est réalisée en utilisant les données issues de l'évaluation des données cliniques, des conclusions issues du PSUR et du PMS et des éléments produits par la gestion des risques.

Dans le cas de produits n'ayant pas de destination médicale listés à l'Annexe XVI du Règlement (UE) 2017/745, les exigences générales en matière de sécurité établies aux points 1 et 8 de l'Annexe I du Règlement (UE) 2017/745 sont interprétées en ce sens que le produit utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination, présente un risque nul ou un risque qui n'est pas supérieur au risque maximum acceptable lié à l'utilisation du produit, de manière à garantir un niveau élevé de protection de la sécurité et de la santé des personnes.

17 DOSSIER DE GESTION DES RISQUES

17.1. Description des méthodes d'analyse de risques, de la maîtrise des risques et identification de la norme de référence (exemple : NF EN ISO 14971, version en vigueur).

17.2. Définition du cycle de vie du dispositif : conception, ..., vieillissement, élimination.

17.3. Dossier de gestion des risques complet comprenant (selon EN ISO 14971, version en cours) :

17.3.1 Plan de gestion des risques.
17.3.2 Synthèse des étapes de la gestion des risques : analyse, évaluation des risques, mise en œuvre et vérification des mesures de maîtrise des risques, évaluation de l'acceptabilité de tout risque résiduel, y compris global.
17.3.3 Rapport (compte rendu de revue du processus de gestion des risques).

Note 17.1 :
- Les risques associés à toutes les phases du cycle de vie du dispositif médical (conception, fabrication, utilisation, vieillissement, élimination) sont à évaluer et à maîtriser ;
- Il est important d'identifier de manière claire et documentée les critères de décision, ainsi que leur justification, qui ont conduit à reconnaître que les risques sont acceptables au regard du bénéfice attendu par le patient ;
- Tous les phénomènes dangereux connus et prévisibles ainsi que les situations dangereuses (combinaison ou séquence d'évènements) doivent être identifiés ;
- L'acceptabilité du risque sous des conditions spécifiées doit se faire en référence « à l'état de l'art généralement reconnu » ;
- Les risques résiduels et leur traitement doivent être identifiés. Il doit être statué sur l'acceptabilité du risque résiduel global. Les bénéfices médicaux supérieurs au risque résiduel doivent être mentionnés.

Note 17.2 : Dans le cas de produits n'ayant pas de destination médicale listés à l'Annexe XVI du Règlement (UE) 2017/745, se référer aux exigences de gestion des risques définies dans le Règlement d'exécution (UE) 2022/2346.

II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION (suite)

VII – VÉRIFICATION ET VALIDATION DU PRODUIT

18	**DONNÉES PRÉCLINIQUES : DÉMONSTRATION DE CONFORMITÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF MÉDICAL, EN LIEN AVEC LES NORMES, DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE ET/OU ÉTAT DE L'ART APPLIQUÉ EN VUE DE DÉMONTRER LA SÉCURITÉ PRÉCLINIQUE DU DISPOSITIF ET LE RESPECT DES SPÉCIFICATIONS**
18.1	**ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION CONCERNANT L'UTILISATION D'AUTRES MATÉRIAUX OU SUBSTANCES** • Éléments de réflexion concernant l'utilisation d'autres matériaux ou substances ; • Justification portant sur le choix des matériaux ou substances au regard des alternatives disponibles.
18.2	**PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANS UNE CONCENTRATION SUPÉRIEURE À 0,1% EN FRACTION MASSIQUE (m/m) PAR LE DISPOSITIF (SI APPLICABLE)** Informations indiquant si le(s) dispositif(s), objet de la présente évaluation, ou les parties de dispositifs ou matériaux utilisés sont : • Invasifs et entrent en contact direct avec le corps humain, ou ; • Destinés à (ré)introduire et/ou prélever un médicament, des fluides corporels ou d'autres substances, dont des gaz, dans le corps, ou ; • Destinés à transporter ou stocker des médicaments, des fluides corporels ou d'autres substances, dont des gaz, destinés à être (ré)introduits dans le corps. Si oui, à au moins une de ces questions : • Indiquer si présence de substances dans une concentration supérieure à 0,1% en fraction massique des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A et 1B ou des substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien (visée à l'Annexe I, section 10.4.1 du Règlement (UE) 2017/745) / Identification de la (ou des) substance(s) concernée(s) et quantité présente ; • Justification portant sur la présence de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et/ou perturbateurs endocriniens. Cette justification repose sur les éléments suivants : - Une analyse et une estimation de l'exposition potentielle du patient ou de l'utilisateur ou du consommateur* à la substance avec identification de la concentration en fraction massique ; - Une analyse des substances, matériaux ou conceptions de substitution possibles, y compris des informations sur la recherche indépendante, les études ayant fait l'objet d'une évaluation par les pairs et les avis scientifiques des comités scientifiques concernés, lorsqu'ils sont disponibles, ainsi qu'une analyse de la disponibilité de ces solutions de substitution ; - Des arguments expliquant pourquoi les substances et/ou matériaux de substitution, s'ils sont disponibles, ou une modification de la conception, si elle est réalisable, ne conviennent pas pour maintenir le fonctionnement, les performances et le rapport bénéfice/risque du produit ; y compris la prise en compte du fait que l'utilisation prévue des dispositifs inclut le traitement d'enfants ou de femmes enceintes ou allaitantes ou d'autres groupes de patients considérés comme particulièrement vulnérables à ces substances et/ou matériaux ; - Le cas échéant et s'il en existe, les orientations les plus récentes du comité scientifique concerné, conformément aux sections 10.4.3 et 10.4.4 du Règlement (UE) 2017/745. **Note 18.2 :** Dans le cas de produits n'ayant pas de destination médicale listés à l'Annexe XVI du Règlement (UE) 2017/745, le terme "rapport bénéfice/risque" est à remplacer par le terme "risque".

II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION (suite)

VII – VÉRIFICATION ET VALIDATION DU PRODUIT

18.3

PRÉSENCE DE DÉRIVÉS DE SUIF ANIMAL

Informations indiquant si le (ou les) dispositif(s), objet de la présente évaluation, ou les parties de dispositifs ou matériaux utilisés sont destinés à entrer en contact avec le corps humain ou avec une peau non intacte.

Si oui :
- Indiquer si présence de dérivés du suif animal susceptibles d'avoir été utilisés notamment dans des procédés de transformation des matières plastiques et/ou de matériaux de conditionnement de ces dispositifs médicaux/Identification de la (ou des) substance(s) concernée(s).

Note 18.3.1 : Le suif étant de la graisse obtenue à partir de tissus animaux, incluant les zones sous-cutanées, abdominales et intermusculaires et les os.

- Liste des composants et des matières premières pour lesquels des matériaux d'origine animale sont utilisés dans leurs procédés de fabrication, ainsi que l'identification de leurs fournisseurs (le contact ou non avec le patient et/ou l'utilisateur et/ou le consommateur* est également à préciser) ;
- Copie des attestations des fournisseurs incluant les informations nécessaires relatives aux paramètres de fabrication des dérivés du suif, pour permettre de statuer sur l'applicabilité ou non du Règlement (UE) n°722/2012 (c.-à-d. identification des matières plastiques et/ou matériaux de conditionnement concernés, ainsi que les conditions de fabrication appliquées aux dérivés du suif) ;
- Justification documentée sur l'applicabilité ou non du Règlement (UE) n°722/2012, sur la base des attestations des fournisseurs.

Note 18.3.2 : Des démarches règlementaires complémentaires pourraient être à effectuer dans le cas où le Règlement (UE) n°722/2012 s'avèrerait applicable.

II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION (suite)

VII – VÉRIFICATION ET VALIDATION DU PRODUIT

18.4

ÉVALUATION MÉCANIQUE, PHYSIQUE, CHIMIQUE, ÉLECTRIQUE, ETC.

Rapports relatifs aux essais réalisés accompagnés du certificat du laboratoire ayant réalisé les essais (exemple : accréditation 17025) et justificatif de l'absence d'essais précliniques.

Note 18.4.1 : Lorsque le dispositif est destiné à être utilisé à l'état stérile, les essais sont à réaliser sur le dispositif stérile.

Par ailleurs, lorsqu'une évaluation fait référence à un rapport d'évaluation ou document de l'entreprise qui a plus de 5 ans, la donnée correspondante doit être transmise et faire l'objet d'une justification de son applicabilité.

Note 18.4.2 : La présentation des résultats se fait de préférence sous forme de tableau. Exemple ci-dessous :

Norme / Document / État de l'art	Caractéristique / Spécification	Exigences / Critères d'acceptation	Méthode de démonstration de conformité à l'exigence (essai, justification)	Identification du laboratoire (nom et adresse) Identification de l'accréditation et date fin de validité	Référence rapport	Justification du worst case	Résultat de conformité

Définitions :
- Caractéristique : propriété intrinsèque du dispositif médical
- Spécification : document formulant des exigences relatives à une caractéristique
- Exigence : attente formulée, implicite ou obligatoire
- Conformité : satisfaction d'une exigence

Note 18.4.3 : Dans le cas où des essais n'ont pas été réalisés conformément aux dispositions des normes ou référentiels applicables, le fabricant devra documenter la démonstration d'équivalence des solutions adoptées.

Note 18.4.4 : Lorsque les calculs (y compris par éléments finis) et les simulations ne permettent pas de démontrer l'atteinte des performances assignées par le fabricant et le cas échéant la conformité du dispositif aux normes ou référentiels applicables, le fabricant doit envisager la nécessité de confirmer ces simulations et calculs par des essais.

Note 18.4.5 : La justification de l'absence de données précliniques est à transmettre. Par ailleurs, lorsqu'une évaluation fait référence à un rapport d'évaluation ou document de l'entreprise qui a plus de 5 ans, la donnée correspondante doit être transmise et faire l'objet d'une justification de son applicabilité.

Note 18.4.6 : Pour les dispositifs émettant des radiations et les dispositifs électriques, leur sécurité quant à ces caractéristiques doit être prise en compte.

Note 18.4.7 : Lorsque des études ont été menées sur des modèles animaux, des informations détaillées doivent être fournies, notamment sur les objectifs d'études, la méthodologie, les résultats, les analyses et les conclusions, y compris le rationnel et les limites de la sélection du (ou des) modèle(s).

Note 18.4.8 : Lorsque des essais de simulation d'utilisation ont été réalisés, le fabricant doit en fournir des informations détaillées.

Note 18.4.9 : Dans le cas où le fabricant réaliserait les essais précliniques en interne ou dans un laboratoire non accrédité 17025, GMED se réserve la possibilité de demander les validations correspondantes des méthodes d'essai mises en œuvre.

Note 18.4.10 : En cas d'examen UE de type, cette section est à réaliser conjointement avec le rapport d'examen UE de type.

Note 18.4.11 : Dans le cas de produits n'ayant pas de destination médicale listés à l'Annexe XVI du Règlement (UE) 2017/745, la vérification des mesures de maîtrise de risques spécifiques listées dans les annexes applicables du Règlement d'exécution (UE) 2022/2346 et relatives à des exigences portant sur la conception du produit sont à prendre en considération.

II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION (suite)

VII – VÉRIFICATION ET VALIDATION DU PRODUIT	18.5	**DANS LE CAS DES DISPOSITIFS MIS SUR LE MARCHÉ AYANT UNE FONCTION DE MESURAGE** Description des méthodes utilisées pour garantir l'exactitude indiquée dans les spécifications.
	18.6	**SI LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE RACCORDÉ À UN OU PLUSIEURS AUTRES DISPOSITIFS POUR POUVOIR FONCTIONNER COMME PRÉVU** 18.6.1. Description du raccordement/de la configuration à fournir. 18.6.2. Incluant la preuve qu'il/elle est conforme aux exigences générales en matière de sécurité et de performances pour tous les dispositifs concernés une fois connectés, au regard des caractéristiques indiquées par le fabricant.
	18.7	**DÉMONSTRATION DU MAINTIEN DES CARACTÉRISTIQUES** 18.7.1. Dans le cadre de l'étude de stabilité de façon à justifier le délai de péremption (en tenant compte des cycles de vie du dispositif). 18.7.2. Pendant la durée de vie attendue des dispositifs. 18.7.3. Validation du retraitement du dispositif, le cas échéant.
	18.8	**CONCLUSION DU FABRICANT** Conclusion du fabricant en tenant compte des éléments de réflexion concernant l'utilisation d'autres matériaux ou substances.
	18.9	**INGÉNIERIE DE L'APTITUDE À L'UTILISATION** Rapport d'aptitude à l'utilisation et identification de la norme de référence (exemple : CEI 62366-1, version en vigueur). **Note 18.9 :** Dans le cas dispositifs ayant à la fois une destination médicale et non médicale, l'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation pour la destination médicale et non médicale est à présenter pour chacune des destinations.

II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION (suite)

VIII – SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION	19	**DESCRIPTION DES DISPOSITIONS PRISES POUR LA SURVEILLANCE DU DISPOSITIF APRÈS COMMERCIALISATION, Y COMPRIS LE PLAN DE SUIVI CLINIQUE APRÈS COMMERCIALISATION (SCAC)** **Note 19 :** Dans le cas de dispositifs ayant à la fois une destination médicale et non médicale, la description des dispositions prises pour la surveillance du dispositif après commercialisation, y compris le plan de suivi clinique après commercialisation (SCAC), pour la destination médicale et non médicale est à présenter pour chacune des destinations. 19.1. Plan de surveillance après commercialisation, conformément à l'annexe III section 1.1 du Règlement (UE) 2017/745. 19.2. Plan de suivi clinique après commercialisation (SCAC). 19.3. Rapport périodique actualisé de sécurité (PSUR), conformément à l'article 86 du Règlement (UE) 2017/745. 19.4. Rapport de surveillance après commercialisation, conformément à l'article 85 du Règlement (UE) 2017/745. 19.5. Rapport d'évaluation du SCAC. 19.6. Évolutions des dispositions et raisons de la modification des dispositions.
	20	**DONNÉES POST-MARCHÉ** **Note 20 :** Dans le cas de dispositifs ayant à la fois une destination médicale et non médicale, les données post-marché pour la destination médicale et non médicale sont à présenter pour chacune des destinations. 20.1. Date de mise sur le marché. 20.2. Nombre de produits vendus en Europe et hors Europe. 20.3. Estimation de la population qui utilise le dispositif (taille et caractéristique de la population). 20.4. Nombre et type de réclamations liées aux caractéristiques techniques, à la performance clinique et à l'aptitude à l'utilisation du dispositif relevées depuis la mise sur le marché ou le marquage CE initial. **Note 20.4 :** Dans le cas de produits n'ayant pas de destination médicale listés à l'Annexe XVI du Règlement (UE) 2017/745, les revendications relatives aux performances cliniques sont limitées à la capacité du produit à atteindre sa destination prévue. 20.5. Nombre et type de signalements de matériovigilance relevés depuis la mise sur le marché ou le marquage CE initial. 20.6. Données issues d'études cliniques, incluant le suivi clinique post-marché et les registres. 20.7. Modifications et/ou actions correctives prises suite aux incidents relevés et révision éventuelle du dossier de gestion des risques.

II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION (suite)

ANNEXES OBLIGATOIRES

1 IDENTIFICATION DES MATIÈRES PREMIÈRES, ADDITIFS, CONTAMINANTS, RÉSIDUS DE PROCESSUS DE FABRICATION ET ARTICLES DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

1. Spécifications des matières premières (cf. note) : physiques, chimiques, biologiques, etc. avec leur référence, numéro de révision et date de révision.
2. Spécifications des additifs, des contaminants et des résidus de processus de fabrication (cf. note) : physiques, chimiques, biologiques, etc. avec leur référence, numéro de révision et date de révision.
3. Spécifications du conditionnement primaire (celui en contact direct avec le dispositif médical) (cf. note) avec sa référence, numéro de révision et date de révision.

Note : Matières premières, additifs, contaminants, résidus de processus de fabrication et articles de conditionnement primaire dont le changement peut remettre en question la conformité aux exigences générales en matière de sécurité et de performances.

Note : La liste des spécifications requises aux points précédents, ainsi que le nom et l'adresse des fournisseurs et distributeurs, sont à transmettre selon le format suivant, sous format électronique copiable :

Matières premières, additifs, contaminants, résidus de processus de fabrication et articles de conditionnement primaire	Spécifications (Caractéristiques physique, de surface, composition chimique, dimension, etc.)	Fournisseur / Adresse	Distributeur / Adresse

2 LOGIGRAMME DE FABRICATION ET CONTRÔLES

Logigramme de fabrication identifiant les procédés mis en œuvre en précisant s'ils sont validés ou vérifiés, ainsi que les contrôles en cours de fabrication et finaux réalisés, y compris lorsque des étapes sont sous-traitées.

3 IDENTIFICATION DES PROCÉDÉS VALIDÉS

La liste des procédés validés est à transmettre. Celle-ci doit à minima identifier les informations suivantes :

1. Description du procédé validé avec l'identification précise de l'équipement concerné ;
2. Identification des rapports de validation associés (QO/QP) avec leur référence, numéro de révision et date de révision ;
3. Identifications des paramètres critiques du procédé ainsi que les intervalles de tolérance validés (mini/maxi).

Note : La liste des procédés validés est à transmettre selon le format suivant, également sous format électronique copiable :

Description du procédé validé	Identification de l'équipement	Rapports de validation (QO/QP) (Réf. / Rév. / date)	Paramètres critiques et intervalles de tolérance validés (Mini/Maxi)
Procédé	*Équipement*	*Rapport Réf. Rév. Date*	*Paramètre Critique 1 ± X*
			Paramètre Critique 2 ± X
			Paramètre Critique 3 ± X

4 LISTE DES NORMES ET DOCUMENTS APPLIQUÉS

Liste des spécifications communes (exemple : Règlement d'exécution (UE) 2022/2346 pour les produits n'ayant pas de destination médicale listés à l'Annexe XVI du Règlement (UE) 2017/745), des normes harmonisées ou non-harmonisées et autres documents (exemple : monographies Pharmacopée Européenne) appliqués.

Lorsque les normes harmonisées ne sont pas utilisées, les solutions mises en œuvre doivent être équivalentes et l'équivalence documentée.

Note : Ce document est à transmettre également sous format électronique copiable.

II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D'UNE ÉVALUATION (suite)

ANNEXES COMPLÉMENTAIRES

1	ÉVALUATION DES DONNÉES CLINIQUES
	Cf. Guide : Évaluation Clinique - Résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques
2	ÉVALUATION DES DONNÉES CLINIQUES DES PRODUITS N'AYANT PAS DE DESTINATION MÉDICALE (ANNEXE XVI DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745)
	Cf. Guide : Évaluation Clinique - Résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques
3	ÉVALUATION BIOLOGIQUE
	Cf. Guide : Évaluation biologique des dispositifs médicaux selon la norme ISO 10993-1 *Cf. Fiche technique : Rapport d'évaluation biologique - Éléments à fournir*
4	VALIDATION DES PROCÉDÉS : NETTOYAGE, DÉSINFECTION
	Cf. Fiche technique : Procédé de nettoyage – Éléments à fournir
5	VALIDATION DES PROCÉDÉS : CONDITIONNEMENT
	Cf. Fiche technique : Procédé de système d'emballage pour les dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal – Éléments à fournir
6	VALIDATION DES PROCÉDÉS : STÉRILISATION
	Cf. Fiche technique : Procédé de stérilisation par irradiation - Éléments à fournir *Cf. Fiche technique : Procédé de stérilisation par oxyde d'éthylène - Éléments à fournir* *Cf. Fiche technique : Procédé de stérilisation à chaleur humide - Éléments à fournir*
7	UTILISATION DE MATÉRIAU D'ORIGINE ANIMALE
	Cf. Fiche technique : Matériau d'origine animale - Éléments à fournir
8	DISPOSITIF INCORPORANT UN MÉDICAMENT
	Cf. Fiche technique : Substance médicamenteuse incorporée à titre accessoire dans un dispositif médical - Éléments à fournir
9	DISPOSITIFS COMPOSÉS DE SUBSTANCES OU DE COMBINAISONS DE SUBSTANCES QUI SONT ABSORBÉES PAR LE CORPS HUMAIN OU DISPERSÉES LOCALEMENT DANS CELUI-CI
	Cf. Fiche technique : Dispositifs médical composé de substances ou de combinaisons de substances destinées à être introduites dans le corps humain par un orifice du corps ou par application sur la peau et absorbées par le corps humain ou dispersées localement dans celui-ci - Éléments à fournir
10	VALIDATION(S) LOGICIEL
	Cf. Fiche technique : Développement et validation de logiciels – Éléments à fournir
11	RAPPORT D'ÉVALUATION EXAMEN DE TYPE ET PROGRAMME D'ESSAI ASSOCIÉ
12	RAPPORT(S) D'EXPERTISE
13	NOTIFIED BODY EVALUATION REPORT PERIODIC SAFETY UPDATE REPORT (PSUR)

→ SIÈGE SOCIAL

GMED SAS
1 rue Gaston Boissier
75015 PARIS • FRANCE
+33 (0)1 40 43 37 00
info@lne-gmed.com

→ BUREAU RÉGIONAL

GMED SAS
19 D rue de la Télématique
42000 SAINT-ETIENNE • FRANCE
+33 (0)4 77 10 11 11

→ FILIALE NORD-AMÉRICAINE

GMED NORTH AMERICA, INC
2600 Tower Oaks Boulevard, Suite 500,
ROCKVILLE, MD 20852 • USA
+1 (301) 495 0477
request@lne-gmed.com

GMED
GROUPE LNE

© mokadesign